

● 文献研究与综述 ●

艾滋病相关性腹泻中药治疗的 Meta 分析*

杨欣怡, 彭鑫, 张春梅, 刘晶晶[△]

(四川省中医药科学院, 四川 成都 610041)

摘要: 目的: 评价及分析中药组方口服治疗艾滋病相关性腹泻 (HIV/AIDS related diarrhea, HRD) 的有效性及其安全性。方法: 计算机检索 CNKI、万方、VIP、Cochrane Library、PubMed 数据库, 查阅所有中药组方口服治疗 HRD 的随机对照试验 (Randomized controlled trial, RCT), 自建库至 2020 年 4 月 30 日发表的文献均纳入检索范围, 手工检索纳入文献的参考文献。根据纳入标准、排除标准筛选合适的文献, 进行资料提取和质量评价后, 采用 RevMan5.3 软件进行 Meta 分析。结果: 共纳入 9 个研究, 539 例患者。Meta 分析结果显示: 中药治疗和西药治疗相比, 疗效指标差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论: 中药治疗与西药治疗相比, 疗效更优, 且有较好安全性, 但所纳入的原始研究质量较低, 需进一步采用大样本、高质量的 RCT 进行论证。

关键词: 艾滋病相关腹泻; 中药; Meta 分析

中图分类号: R 512.91 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-3649 (2021) 07-0214-05

Meta Analysis on AIDS Related Diarrhea Treated by Chinese Herb Medicine/YANG Xinyi, PENG Xin, ZHANG Chunmei, et al. //Sichuan Academy of Chinese Medicine Sciences (Chengdu Sichuan 610041, China)

Abstract: Objective: To analyze and evaluate the effectiveness and safety of Chinese herb medicine treatment for HIV/AIDS related diarrhea. Methods: Lookup data bases as CNKI, Wanfang, VIP, Cochrane Library and PubMed were searched from their establishment to April 30th 2020 for collecting the randomized controlled trials (RCT) about Chinese herb medicine for AIDS related diarrhea, and the references of those RCTs were searched manually. According to the inclusion criteria and exclusion criteria, the appropriate literature were screened, meta-analyses were performed by using the RevMan 5.3 software. Results: Nine studies involving 539 patients were included. The results of meta-analyses showed that: Chinese herb medicine compared with con-

* 基金项目: 四川省科技计划项目基本科研业务专项“健脾温阳解毒法对 HAART 所致药物性腹泻的临床研究”(编号: A-2019N-31); 四川省科技厅科技计划项目“基于邪去正安思想探索愈肠胶囊联合 HAART 促进 HIV 感染者免疫重建、延缓发病的前瞻性临床研究”(编号: 2019YFS0023)。第一作者: 杨欣怡, 中医医师, 硕士, 从事中医药防治重大疾病临床及科研工作。△ 通讯作者: 刘晶晶, 副主任中医师, 研究方向: 中医药治疗艾滋病、皮肤病临床及科研工作, 邮箱: 59298370@qq.com。

参考文献

- [1] 王一吉, 遯晓蕾, 袁媛, 等. 脊髓损伤神经学分类国际标准查表最新修订及解读 [J]. 中国康复理论与实践, 2015, 21 (008): 879-882.
- [2] 黄彬洋, 刘晓瑞, 王文春, 等. “辟谷-服气-服药”三联法治疗脊髓损伤及并发症的理论初探 [J]. 时珍国医国药, 2018, 029 (004): 936-939.
- [3] 郝定均, 贺宝荣, 闫亮, 等. 2011~2013 年西安市红会医院脊柱脊髓损伤患者流行病学特点 [J]. 中华创伤杂志, 2015, 31 (7): 632-636.
- [4] 冉白灵, 韩琳, 王竹行, 等. 中医调理联合肠道管理对高位段脊髓损伤慢性期神经源性肠功能障碍患者的治疗效果 [J]. 山西医药杂志, 2020, 49 (3): 341-344.
- [5] 周谋望. 脊髓损伤神经学分类国际标准 [M]. 人民卫生出版社, 2013.
- [6] 李青, 远丽, 徐青. 女性性功能指数的使用现状 [J]. 中国康复理论与实践, 2014, 20 (011): 1081-1082.
- [7] 刘永闯, 郭丽娜, 刘堃. 沃里克-爱丁堡积极心理健康量表在老年人中应用的效度和信度 [J]. 中国心理卫生杂志, 2016, 30 (3): 174-178, 共 5 页.
- [8] 高雪晓, 朱兰, 於四军, 等. 简体中文版粪失禁生活质量问卷信度和效度分析 [J]. 中华医学杂志, 2018, 098 (011): 813-817.
- [9] 吴承杰, 马勇, 郭杨, 等. 脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍发生机制及诊疗研究进展 [J]. 中华创伤杂志, 2019, 35 (7): 618-624.
- [10] 李强, 章耀华, 刘晓磊, 等. 脊髓损伤患者心理健康状况调查及相关因素分析 [J]. 中国临床医生杂志, 2018, 46 (12): 1462-1465.
- [11] 胡伟, 李萍, 王东, 等. 益气健脾解毒汤改善脊髓损伤神经源性肠道功能障碍的临床对照研究 [J]. 中医药导报, 2015, 021 (013): 77-79.
- [12] 刘亭亭, 刘名名, 马琳. 整体康复护理在改善急性期脊髓损伤患者神经源性肠功能障碍中的作用 [J]. 重庆医学, 2017, 46 (A02): 252-253.
- [13] 孙善斌, 陈四芳, 陈冲, 等. “通督调神”灸法干预脊髓损伤肠道功能障碍: 随机对照研究 [J]. 中国针灸, 2020, 40 (01): 3-7.
- [14] 刘提, 杜元源, 李晶. 针灸治疗脊髓损伤后神经源性膀胱的取穴规律探讨 [J]. 环球中医药, 2017, 10 (005): 604-606.

(收稿日期 2021-01-19)

ventional therapy, the curative effect difference was statistically significant ($P < 0.05$). Conclusion: Comparison of traditional Chinese medicine treatment and western medicine treatment, the curative effect is better, and the safety is better. However, because of the lower quality in the original study, we still need to further use more large samples, high-quality RCT to demonstrate.

Keywords: HIV/AIDS related diarrhea; Chinese herb medicine; Meta analysis

艾滋病相关性腹泻 (HIV/AIDS related diarrhea, HRD) 是艾滋病常见并发症之一, 表现为以持续或间断性水样便, 每日 3 次或 3 次以上, 超过 1 个月, 严重者逐渐出现体重减轻、营养不良等恶病质^[1]。对患者的生活质量影响大, 严重者可以引起死亡, 特别是经济水平较低的国家, 艾滋病相关性腹泻已经是引起患者死亡的主要原因之一, 据文献报道发生率为 30% ~ 80%^[2]。随着高效抗逆转录病毒治疗 (highly active anti-retroviral therapy, HAART) 的普及, 虽能有效抑制 HIV 病毒, 提高免疫水平, 机会性感染的发生率下降, 但与此同时, HAART 所致的药物性腹泻临床上日渐增多。金艳涛^[3]等通过对 426 例 HAART 治疗的不良反应分析报道指出, 抗病毒药物引起消化道不良反应的比例为 22.5%。导致 HRD 的原因包括病原体感染及非感染因素, 随着抗病毒治疗的广泛运用, 非感染性病因种类明显增加, 机会性感染率下降^[4], 从目前许多临床观察报道发现中医药对 HRD 有较好治疗作用, 并且积累了一定的临床经验。本文拟通过对已公开发表的中药组方口服治疗 HRD 的临床随机对照试验文章进行 meta 分析, 以进一步评价其疗效, 为中医在 HRD 治疗提供循证依据, 也为后期中医药在 HRD 方面的研究提供方向。

1 资料与方法

1.1 资料来源 所有文献来源于数据库以及纸质论文集等已发表的有关中药口服治疗艾滋病相关腹泻的随机对照试验类文献。

1.2 方法

1.2.1 文献检索 策略选取自建库至 2020 年 4 月 30 日以来, 来源于以下数据库的文献: 中国知网 (CNKI)、万方数据知识服务平台 (WanFangData)、重庆维普资讯中文期刊服务平台 (VIP)、PubMed、CochraneLibrary。网络检索词: 中文包括“获得性免疫缺陷综合征、人类免疫缺陷病毒、艾滋病、腹泻、中医药、中医、中药、随机”等; 英文包括“AcquiredImmunodeficiencySyndrome、AIDS、diarrhea*、TraditionalChineseMedicine”等。

1.2.2 纳入标准 ①有关中药口服治疗艾滋病相关性腹泻的临床随机对照试验, 语种限中英文; ②基础治疗为 HAART, 观察组干预措施为中药组方口服,

对照组采用安慰剂或阳性药物治疗; ③研究对象为 HIV 感染者/AIDS 患者; ④结局指标: 临床症状改善情况。

1.2.3 排除标准 ①假随机或未提到“随机”的文献; ②试验组予中成药或干预方法同时合并针灸、推拿等非药物疗法。③无法提取具体数据的文献; ④中医理论、传统综述、回顾性分析等; ⑤重复发表、逻辑架构合理性明显欠缺的文献。

1.2.4 资料提取 将检索文献筛选结果导入 Noteexpress 文献管理软件, 由 2 名研究员独立完成文献筛选, 遇到意见不一致的地方, 第三名评价者独立判断, 如仍然未能达成一致意见, 则进行讨论解决。内容包括: 题目、作者、发表年份、干预措施、结局指标、中药组方、研究设计的方法学质量评价要素等。

1.2.5 方法学质量评价 对纳入的文献采用 Cochrane 协作网提供的 Cochrane Reviewer's Handbook 有关随机对照试验的偏倚风险评估工具^[5]进行。根据 Meta 分析结果, 运用 GRADE profiler3.6 软件, 对结局指标的证据质量进行分级评价。

1.3 统计学方法 运用 Revman5.3 软件对结局指标的效应量进行 Meta 分析。对二分类变量采用比值比 (Odds Ratio, OR) 或相对危险度 (Relative Risk, RR) 作为疗效分析统计量, 并对效应量的 95% 作为可信区间 (CI)。运用 χ^2 检验对纳入研究的结果的异质性进行检验, 结合 I^2 的值进行判断: $P \geq 0.1$ 且 $I^2 \leq 50\%$, 表明结果间的统计学异质性较小, 选用固定效应模型; $P < 0.1$ 或 $I^2 > 50\%$, 表明结果的统计学异质性明显, 选用随机效应模型。Meta 分析结果中, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 文献检索与筛选结果 初检文献 150 篇, 其中重复 42 篇, 根据纳入和排除标准, 结合文献题目、摘要及全文, 排除 77 篇; 针对剩下的 31 篇, 二次筛选最终得到 9 篇文献^[6-14], 来源于公开发表文献 7 篇, 来源于会议文献 2 篇, 具体如表 1 所示。纳入研究的总计 539 例患者, 其中试验组 295 例, 对照组 244 例, 所有研究的基线资料均有可比性 ($P > 0.05$)。

表 1 纳入研究的一般特征

研究者	病例数 (T/C)	平均年龄 (T/C)	随机	盲法	试验 周期	干预措施		结局 指标
						T	C	
陈明 2008	80 例 40/40	未描述	未描述	-	4 周	参苓白术散合真人养脏汤: 莲子 20g, 薏苡仁 20g, 砂仁 15g, 桔梗 15g, 白扁豆 10g, 白茯苓 20g, 党参 30g, 白术 30g, 山药 30g, 当归 8g, 肉豆蔻 8g, 肉桂 3g, 炙甘草 5g, 白芍 12g, 木香 6g, 诃子 12g	黄连素片	症状综合改善情况

(续表1)

张怀亮 2005	60 例 (30/30)	33.52 岁 /32.42 岁	未描述	-	30 天	参苓白术散加减: 党参 15g, 黄芪 30g, 白术 15g, 茯苓 18g, 白扁豆 18g, 薏苡仁 18g, 山药 18g, 莲子肉 15g, 陈皮 10g, 桂枝 10g	复方新诺明; 灭滴灵。如无效加氟哌酸, 黄连素	症状综合改善情况
李卓 2016	37 例 (19/18)	35~57 岁 /26~56 岁	随机 数字表	-	2 周	健脾止泻方: 党参 15g, 焦白术 15g, 炮姜 10g, 煨肉豆蔻 15g, 吴茱萸 10g, 五味子 10g, 补骨脂 15g, 炙甘草 6g	诺氟沙星 胶囊	腹泻改善情况
田明 2011	143 例 (96/47)	无	中央随机	-	2 周	健脾止泻方: 生黄芪 20g, 山药 30g, 补骨脂 10g, 炮姜 6g, 黄连 6g, 升麻 12g, 焦白术 10g, 焦山楂 10g, 木香 6g, 葛根 20g, 车前草 15g, 炙甘草 6g	易蒙停	腹泻量表评分及 每日大便总量、 大便次数。病毒 学指标 (HIV - RNA) 等。
任明 2013	28 例 (14/14)	43.6±11.8	未描述	未描述	2 周	健脾止泻配方加减: 山药 30g, 生黄芪 20g, 炮姜 6g, 补骨脂 10g, 升麻 12g, 黄连 6g, 焦山楂 10g, 焦白术 10g, 葛根 20g, 木香 6g, 炙甘草 6g, 车前草 15g	氟哌酸胶 囊; 思密达	临床症状疗效评 价
徐彦飞 2010	43 例 (22/21)	44.23±8.98 /43.79±12.23	未描述	未描述	2 月	升阳除湿汤为基本方加味: 升麻 6g, 柴胡 6g, 羌活 6g, 防风 6g, 半夏 6g, 陈皮 3g, 苍术 12g, 猪苓 3g, 泽泻 6g, 益智仁 6g, 神曲 6g, 木香 6g, 黄连 6g, 甘草 3g, 生姜 3 片, 大枣 2 枚。	庆大霉素 片, 盐酸黄 连素片	临床症状计分; 大便细菌培养; 细胞免疫; 生存 质量评价。
张贺峰 2019	60 例 (30/30)	45.2±2.4 /46.1±2.2	随机数 字表法	-	2 周	芪前苡苓方: 黄芪 30g, 车前子、茯苓、白术、甘草各 20g, 炒薏苡仁、山药、人参、当归、焦山楂各 15g, 陈皮、升麻、柴胡各 10g	洛哌丁胺 胶囊	腹泻改善情况
冀爱英 2005	59 例 (30/29)	36.3/34.5	未描述	-	2 周	木香 6g、砂仁 6g、黄连 10g、党参 12g、炒白术 15g、陈皮 12g、制半夏 10g、茯苓 20g、白扁豆 20g、生甘草 5g、吴茱萸 5g、怀山药 20g、补骨脂 15g、诃子肉 12g、肉豆蔻 15g、大枣 6g	氟哌酸 200mg, 黄 连素 300mg	临床症状疗效评 价
周文劲 2014	32 例 (16/16)	38.56±9.59 /40.12±10.23	未描述	-	2 周	用健脾止泻颗粒进行治疗: 6g 炙甘草、15g 车前草、20g 葛根、6g 木香、6g 炮姜、10g 补骨脂、30g 山药、20g 黄芪、12g 升麻、6g 黄连、10g 白术、10g 山楂	盐酸洛哌 丁胺胶囊	临床疗效比较

2.2 纳入研究的情况和偏倚风险评价 对纳入的研究选择 Cochrane 协作网推荐的偏倚风险评估方法进行评价, 结果提示: 纳入的研究基线可比, 但有不同的水平偏倚 (见图 1~2)。9 个研究均提及“随机”, 其中 2 项^{[8][13]}研究描述为随机数字表, 1 项^[11]研究描述为随机整群单盲设计, 1 项^[8]研究描述为中央随机化系统, 其余未进行详细描述。所有 2 项^{[14][15]}研究提及盲法, 但未具体描述。所有研究均完整报道了研究结果, 均无选择性报道结果。

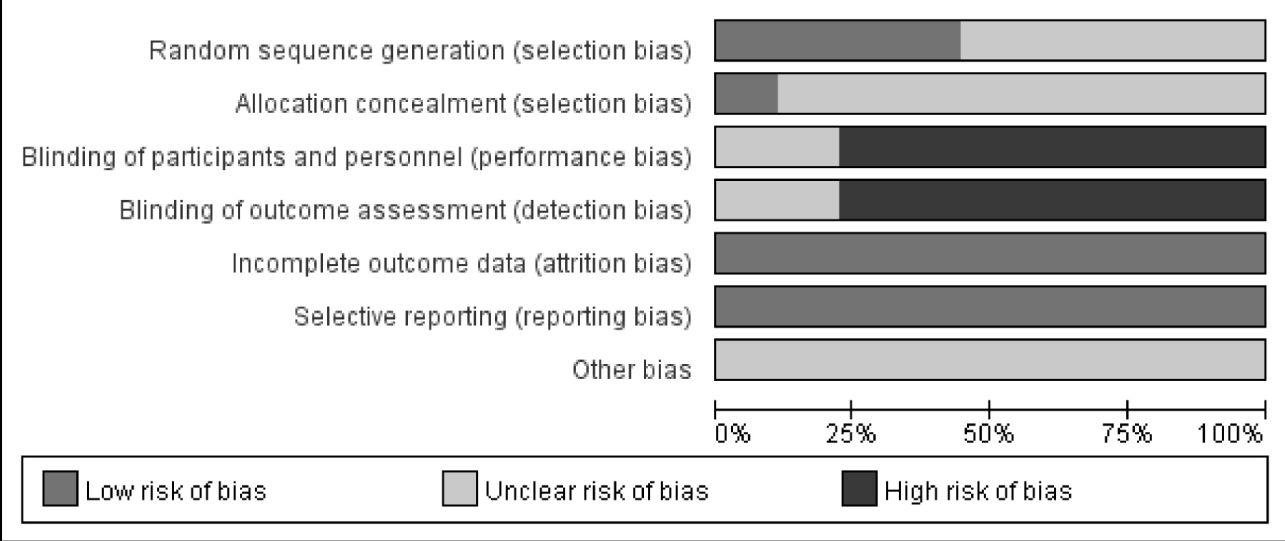


图 1 偏倚风险图 对纳入研究中产生偏倚风险的项目所占百分比的判断

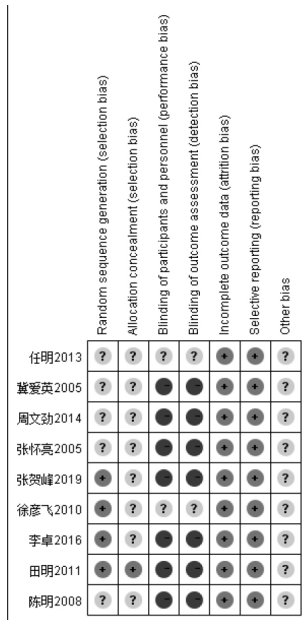


图2 偏倚风险图 对纳入研究中每个偏倚风险项目的判断

2.3 Meta 分析结果 见图3。9个纳入研究间的异质性小 ($P = 0.96$, $I^2 = 0\%$)，分析方法需应用固定

Study or Subgroup	中药		西药		Weight	Odds Ratio
	Events	Total	Events	Total		M-H, Fixed, 95% CI
任明2013	12	14	9	14	5.0%	3.33 [0.52, 21.28]
冀爱英2005	22	30	13	29	13.7%	3.38 [1.14, 10.08]
周文劲2014	14	16	10	16	4.9%	4.20 [0.70, 25.26]
张怀亮2005	25	30	16	30	10.4%	4.38 [1.32, 14.50]
张贺峰2019	28	30	22	30	5.7%	5.09 [0.98, 26.43]
徐彦飞2010	20	22	16	21	5.8%	3.13 [0.53, 18.29]
李卓2016	17	19	13	18	5.5%	3.27 [0.54, 19.62]
田明2011	47	94	15	46	39.1%	2.07 [0.99, 4.32]
陈明2008	36	40	26	40	10.1%	4.85 [1.43, 16.42]
Total (95% CI)		295		244	100.0%	3.23 [2.13, 4.91]
Total events		221	140			
Heterogeneity: Chi² = 2.47, df = 8 (P = 0.96); I² = 0%						
Test for overall effect: Z = 5.51 (P < 0.00001)						

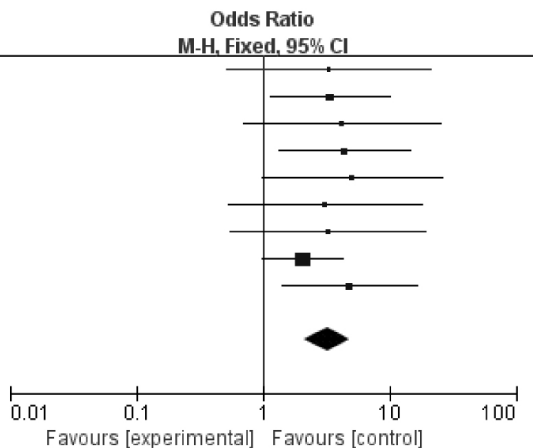


图3 Meta 分析结果

中医学“泄泻”囊括了本文探讨的艾滋病相关腹泻，临床证候特点研究发现其以气虚、脾虚、肾虚、痰湿为主^[4]。疫毒外邪侵袭人体，损伤正气，邪毒内伏，暗耗正气，耗损脾阳，脾阳不升，肠腑传导失司则发为泄泻，反复发作病久不愈，伤及肾阳则迁延难愈。本病病性以虚为主，病位多归于脾肾。纳入的9项研究中，组方治疗病位均在脾，与目前研究的证候研究结论一致，其中7项以健脾止泻为治法，1项以温脾补肾涩肠为治法，1项以升阳除湿为治法。

通过Meta分析发现中药组方口服对艾滋病相关腹泻具有较好治疗作用，无明显不良反应。近年来中药、中成药治疗艾滋病相关腹泻的报道越来越多，证实了中医药治疗的有效性与安全性，但高质量的

效应模型。Meta分析结果表明：临床疗效合并效应量 $[OR = 3.23, 95\% CI (2.13, 4.91)]$, $P < 0.00001$ ，说明中药组方治疗艾滋病相关腹泻，疗效确切，优于西药对照组。

2.4 结局指标的证据强度级别评价 对以上结局指标运用GRADE系统进行证据强度级别评价显示：中药组方治疗艾滋病相关性腹泻的证据质量等级为“低级”。

2.5 药物的安全性 研究过程中未观察到过敏现象、药物不良反应或不良事件以及严重不良反应或不良事件发生，说明本研究方法是安全的。

3 讨论

艾滋病相关性腹泻的常见原因包括原虫、病毒、真菌感染^[4]及肠道菌群紊乱、肠吸收功能障碍等，而使用抗菌药治疗可能加剧肠道菌群失调的发生，对止泻药治标不治本，严重影响患者生存质量。药物性腹泻是艾滋病治疗过程中影响患者服药的常见不良反应之一，包含克力芝的药物组合更易发生腹泻，临床多对症处理或者不处理，从而容易影响患者依从性，最终影响抗病毒疗效。

研究不多，本文主要纳入研究为中药组方口服治疗，排除中成药及中医外治法。由于纳入研究证据质量偏低，临床设计欠规范等因素可能影响结果的可信度。本文纳入的9篇文章存在以下不足：

1) 由于本研究治疗方法为我国传统中医药治疗方法，主要研究地点在国内，均为中文文献，存在一定地域倾向性，可能影响结果的可信度。

2) 纳入的文献中，部分临床研究证据等级偏低，并不完全是标准的、高质量的RCT，一定程度影响了结果的可靠性。

3) 本研究所筛选文献主要根据艾滋病相关腹泻的临床疗效变化情况进行有效性判定，该指标存在一定的主观性，且相对单一，可能影响结果可信度，且可能存在发表偏倚。

中医药干预桥本甲状腺炎作用机制研究进展*

秦雅雯, 郑敏[△], 王之莹, 雷佳妮

(上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院内分泌科, 上海 200437)

摘要: 桥本甲状腺炎是一种自身免疫性疾病, 其发病率逐年增加。目前西医临床上尚无根治之法, 中医强调整体观念辨证论治且具有丰富的临床经验使其在治疗桥本甲状腺炎方面具有一定的优势, 且现代生物学技术研究表明中医药多机制、多靶点的作用方式在治疗桥本甲状腺炎的过程中起到重要作用。近年来, 中医药在治疗桥本甲状腺炎方面的研究不断深入, 越来越多的中药复方及单味中药被证实可以通过调节免疫来防治桥本甲状腺炎。因此本文整理了近年来中医药干预桥本氏甲状腺炎作用机制研究成果, 结果表明中医药可能通过降低甲状腺抗体、调节 T 淋巴细胞平衡、调节炎症因子分泌来改善桥本甲状腺炎。有一定的动物试验研究结果, 但对于中医药调节甲状腺异常细胞凋亡的临床试验研究匮乏, 这个有待进一步研究探索, 以为未来更好探究中医药治疗桥本氏甲状腺炎提供参考。

关键词: 中医药; 桥本甲状腺炎; 作用机制; 研究进展

中图分类号: R 581.4 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-3649 (2021) 07-0218-05

Research Progress on the Mechanism of Traditional Chinese Medicine for Intervening Hashimoto's Thyreoiditis/QIN Yawen, ZHENG Minchen, WANG Zhiying, et al. //Department of Endocrinology, Yueyang Hospital of Integrated Traditional

* 基金项目: 上海市中医药领军人才培养计划 (编号: ry410.05.12)。作者简介: 秦雅雯, 硕士研究生在读, 主要从事内分泌研究; [△]通讯作者: 郑敏, 硕士, 主任医师, 主要从事中西医结合内分泌、代谢性疾病研究, E-mail: sammyzh@126.com。

4) 目前纳入的文献对于有效性的评判指标有细微差别, 尚无统一判断标准, 其中有 5 项^[7,8,11,12,14] 研究参照《中药新药临床指导原则》的疗效评价标准, 但症状好转百分比也并不统一; 其余 3 项^[6,10,13] 则以大便次数恢复情况判断, 无具体百分比; 1 项^[9] 以大便总量的变化进行判定。

综上所述, 从目前的临床报道来看, 中医药治疗艾滋病相关腹泻在大便次数恢复、临床症状改善等方面具有较好疗效, 但是并未有实验室等客观指标来证实, 如何更好发挥并验证中医药治疗作用, 还需要进一步进行临床观察及实验室研究, 同时观察指标、疗效评价标准还需进一步统一。健脾止泻是目前研究的主要方向, 但是最佳组方还需进一步提炼和探索, 希冀将来有更多更严谨的大样本 RCT 提供证据支持。

参考文献

- [1] Lew EA, Poles MA, Dieterich DT. Diarrheal disease associated with HIV infection [J]. Gastroenterol Clin North Am, 1997, 26: 259-290.
- [2] Nsagha DS, Njunda AL, Assob NJC, et al. Intestinal parasitic infections in relation to CD4+T cell counts and diarrheal HIV/AIDS patients with or without antiretroviral therapy in Cameroon [J]. BMC Infect Dis, 2016, 16: 9.
- [3] 金艳涛, 姜枫, 郭会军, 等. HAART 药物及不同组合不良反应的对应分析 [J]. 现代预防医学, 2013, 0 (6): 1075-1085.
- [4] 周玉玲, 王玉光, 李坪, 等. 311 例艾滋病相关性腹泻的临床研究 [J]. 中华实验和临床感染杂志 (电子版), 2012, 6 (3): 191-194.
- [5] Higgins JPT, Green S (editor). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [update March 2011]. [EB/OL]. The Cochrane Collaboration, 2011, Available at: www.cochrane-handbook.org.
- [6] 陈明, 陈铿, 杨慧芳. 参苓白术散合真人养脏汤治疗艾滋病腹泻 40 例的疗效观察 [J]. 甘肃中医, 2008, (11): 22-23.
- [7] 张怀亮. 参苓白术散加减治疗艾滋病相关性慢性腹泻 30 例临床观察 [J]. 中华中医药学会防治艾滋病学术研讨会暨 2005 年论文集, 2005.
- [8] 李卓, 袁君, 张晓伟, 等. 健脾止泻方治疗艾滋病相关腹泻脾肾阳虚证 19 例 [J]. 中医研究, 2016, (8): 11-13.
- [9] 田明, 倪量, 万钢, 等. 健脾止泻方治疗艾滋病相关性慢性腹泻的临床研究 [J]. 世界中医药, 2011, (03): 193-195.
- [10] 任明. 健脾止泻方治疗艾滋病相关性慢性腹泻的疗效 [J]. 中医临床研究, 2013, (10).
- [11] 徐彦飞. 李东垣升阳除湿法在艾滋病相关性腹泻救治中的应用及疗效观察 [J]. 河南省中医药大学, 2010.
- [12] 张贺峰. 芪前苡苓方治疗艾滋病相关腹泻脾气虚证的临床疗效观察 [J]. 临床医药文献电子杂志, 2019, 6 (53): 45-46.
- [13] 冀爱英, 杜明瑞, 蒋士卿. 中医药治疗 HIV/AIDS 慢性腹泻 30 例临床观察 [J]. 中华中医药学会防治艾滋病学术研讨会暨 2005 年论文集, 2005.
- [14] 周文劲. 中医治疗艾滋病患者腹泻的临床研究 [M]. 世界最新医学信息文摘电子版, 2014.
- [15] 于艳华, 陈铭, 孙丽君, 等. 艾滋病慢性腹泻患者肠道细菌及真菌感染的研究 [J]. 中华医院感染学杂志, 2011, (12): 2632-2633.
- [16] 丁洋. 艾滋病相关腹泻的中医证候研究 [D]. 北京中医药大学, 2008.

(收稿日期 2020-07-14)